

尿液改道 — 比較各種選擇

WARWIKI

病人須知 · 當膀胱切除或無法正常運作時，三種排尿方式

當膀胱切除咗或者唔能夠正常運作，尿就需要一條新出路離開身體 — 呢個叫做尿液改道。主要有三種方法，都係用你自己嘅一小段腸。最大分別係你每日點樣排尿：用肚皮上嘅袋、經尿道自然排尿、或者用尿管導流。呢張紙比較三種方法；每種都有獨立詳細的病人須知。

三種選擇

需要佩戴造口袋

迴腸導管 (Ileal Conduit)

一小段腸將尿引到肚皮上一個小開口（**造口**），尿液持續流入一個輕便**造口袋**，你定期清空並換袋。做法最簡單，最為常見；唔需要控制或導尿。

經尿道自然排尿 · 唔需要袋

原位新膀胱 (Orthotopic Neobladder)

用腸造一個新儲尿囊，接駁到你嘅**尿道**，讓你自然排尿，唔需要袋。你要按**時間表**排尿（日夜均需），有時要用尿管，初期可能會有漏尿。

用尿管導流 · 唔需要袋

可控皮膚造口 (Indiana Pouch)

用腸造一個內置儲尿囊，有一個細小防漏開口（通常喺**肚臍**位置）。唔需要袋 — 你每日幾次將**尿管**插入開口導尿。

詞彙解釋

尿液改道

當膀胱切除或失去功能，尿液離開身體嘅新路徑。

造口 (Stoma)

肚皮上由腸造成嘅小開口，尿液經此流出。

導管 (Conduit)

一小段腸，將尿引到造口（唔儲尿）。

新膀胱 (Neobladder)

用腸造嘅新膀胱，連接尿道。

可控 (Continent)

防止漏尿 — 由你決定幾時排空。

不可控改道

持續流尿入袋（即迴腸導管）。

導尿 (Catheterize)

插入細管排出尿液。

黏液 (Mucus)

腸壁分泌嘅滑性液體；改道後尿液中有黏液絲係正常現象。

邊種方法最適合我？ 最佳選擇取決於你嘅解剖結構、腎功能、其他健康狀況，以及你嘅手部力量同視力（導尿時需要）— 仲有你嘅生活方式同你最重視嘅事。唔係每個人都適合每種方法。你嘅外科醫生會話俾你聽哪些方法對你係安全嘅。

三種方法比較

	迴腸導管	新膀胱	可控造口 (Indiana)
排尿方式	自動流出	經尿道排尿	尿管經造口導尿
需要佩戴袋？	係	唔需要	唔需要
需要導尿？	唔需要	有時需要	每 4-6 小時一次
手術規模	最細	較大	較大
日常護理	清空 & 換袋	定時排尿 (日夜)	導尿 & 沖洗

問你嘅外科醫生

- 我適合哪些方法？你建議我選哪種？
- 每種方法嘅日常生活同自我護理係點？
- 會點影響工作、運動、睡眠同親密關係？
- 主要風險係咩？日後需要再做手術嘅機會有幾大？

三種方法共同之處

- 三種方法都會用你自己嘅腸，所以手術後腸需要幾日恢復。
- 尿液中有黏液係正常嘅 — 腸壁本身會分泌黏液。
- 你需要終身定期覆診，包括定期檢查維他命 B12（腸段會令 B12 多年後下降）。
- 多飲水有助沖走積聚物。

要記住嘅三件事

1. 尿液改道有三種方式 — 造口袋（迴腸導管）、經尿道自然排尿（新膀胱）、或者用尿管經小開口導尿（Indiana Pouch）。
2. 三種方法嘅最大分別係日常護理。最適合你嘅選擇取決於你嘅健康狀況同你最重視嘅事 — 而且唔係每個人都適合每種方法。
3. 三種方法都用到腸，所以都會有尿液中黏液、腸需要幾日恢復、同需要終身覆診呢啲共同點。選定方案後請閱讀相應嘅詳細病人須知。